Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent9vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5024209-46.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: SUSANA BANDEIRA DE MENEZES

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

SUSANA BANDEIRA DE MENEZES ajuizou *ação ordinária* em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, partes já qualificadas. Narrou que é portadora de asma grave alérgica (CID 10: J45.0), doença inflamatória crônica que compromete as vias aéreas, frequentemente resultando em sintomas severos. Referiu que, após tratamentos convencionais inadequados para controle da doença, a médica assistente prescreveu o medicamento biológico Tezepelumabe (Tezspire), indicado para reduzir exacerbações, melhorar a função pulmonar e evitar os riscos de efeitos colaterais graves do uso contínuo de corticosteroides. Alegou que recebeu a negativa para o fornecimento do medicamento pela ré, sob o argumento de que o Tezepelumabe não consta no rol da ANS e não preenche os requisitos das normas aplicáveis. Sustentou que a negativa era abusiva e contrária às disposições do Código de Defesa do Consumidor e à Lei n.º 9.656/98, que garante a cobertura de tratamentos eficazes prescritos por médicos assistentes, mesmo fora do rol da ANS, desde que demonstrada a eficácia e necessidade. Pediu em tutela de urgência o fornecimento ou custeio imediato do Tezepelumabe pela ré, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela condenação definitiva do plano de saúde ao fornecimento ou custeio do medicamento, conforme prescrição médica, de forma contínua e por tempo indeterminado. Pediu a gratuidade da justiça. Juntou documentos.

Deferida a gratuidade à autora e concedido o pleito antecipatório **(Evento 6)**.

Citada, a ré contestou **(Evento 14)**. Impugnou o valor da causa, requerendo fosse fixado no valor de alçada, e, alternativamente, que a autora aprestasse outros dois orçamentos para apuração do menor valor praticado no mercado, visando adequar o valor da causa. Afirmou que o contrato da autora é regulamentado pela Lei n.º 9.656/98 e pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que a negativa de cobertura do medicamento Tezepelumabe 210 mg fundamentou-se no não preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n.º 65 da Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, que regula tratamentos imunobiológicos para asma alérgica grave. Destacou que a patologia da autora – asma grave alérgica – estava incluída na lista de doenças para as quais havia cobertura obrigatória, desde que preenchidos critérios específicos, o que não ocorreu, na medida em que a autora apresentava IgE em 20 UI/ml e eosinófilos em 110 células/µL. Sustentou que, conforme a Lei n.º 14.454/22, a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS seria em casos excepcionais. Referiu que, permitir a concessão do medicamento, implicaria impor à operadora obrigações além do contratado, desrespeitando o ato jurídico perfeito e prejudicando a coletividade de beneficiários. Pediu a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Houve réplica **(Evento 18)**.

Intimadas as partes a dizerem sobre o interesse na produção de provas, nada requereram.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas, conforme dita o artigo 355, I, do CPC.

O valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico é estipulado com base no **artigo 292 do Código de Processo Civil (CPC)**, que estabelece, em seu **inciso V, que** o valor da causa deve corresponder "ao benefício econômico perseguido pelo autor".

Assim, se a autora busca o fornecimento de um medicamento ou tratamento de custo definido, o valor da causa pode ser estipulado com base no valor total do tratamento requerido.

No caso em debate, devido ao fato do tratamento se dar por prazo indeterminado, a autora estabeleceu o valor anual **(12 meses)**, do fornecimento da medicação pretendida, nada havendo a reparar quanto ao ponto.

Passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação de fazer, em que a autora, portadora de asma grave, pretende o fornecimento de medicamento/custeio de tratamento de Tezepelumabe (Tezspire), em vista da negativa de fornecimento pela ré.

De início, observo que a relação entretida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, o que já se encontra sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)."

Tratando-se de demanda envolvendo o dever do plano de saúde em custear tratamento médico, é fundamental lembrar que está em jogo um direito fundamental, o direito à saúde, classificado como direito de segunda geração e expressamente assegurado pela Constituição Federal, conforme disposto nos artigos 6º e 196, cujos termos destacam a relevância desse direito como garantia essencial.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No tocante ao direito à saúde suplementar, a legislação pátria compreende determinados normativos, isto é, a Lei nº 9.656/1998 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, os quais conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde.

No caso sub judice, a doença é coberta pelo contrato, e o medicamento foi prescrito à autora pelo médico assistente, sob alegação de que a paciente/autora, com o uso somente de corticóides e demais medicações inalatórias, ainda apresentava repetidas exacerbações.

A demandada negou a cobertura postulada, argumentando que não preenchidos os requisitos da Diretriz de Utilização n.º 65 da Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS, referindo que a IgE sérica total da requerente, antes do início do tratamento, seria menor a 30 UI/ml, conforme colaciono (Anexo II da Resolução 465/2021):

65.10 ASMA ALÉRGICA GRAVE

*1. Cobertura **obrigatória** dos medicamentos Omalizumabe ou Dupilumabe1 ou **Tezepelumabe2** para o tratamento complementar da asma alérgica grave, quando preenchidos todos os seguintes critérios:*

*a. asma não controlada, **apesar do uso de corticoide inalatório** associado a beta 2 agonista de longa duração; e*

b. evidência de sensibilização a pelo menos um aeroalérgeno perene documentada por teste cutâneo de puntura ou dosagem de IgE sérica específica in vitro; e

*c. IgE sérica total, antes do início do tratamento, **maior ou igual a 30 UI/ml**; e*

*d. **uso contínuo de corticoide oral para controle da asma nos últimos 6 meses ou 3 ou mais exacerbações asmáticas necessitando de tratamento com corticoide oral no último ano.***

Observação:

2. Incluído pela RN nº 612/2024, a partir de 02/09/2024

No entanto, a necessidade do tratamento vem evidenciada pelo documento do **Evento 1, LAUDO4**, e a **evolução do quadro da autora** com o uso da medicação está demonstrada no Laudo do **Evento 18, LAUDO 2**, que assim dispõem:

Nesse contexto, com o inadequado controle da asma, apesar das doses elevadas de corticosteroides inalados associados aos outros medicamentos, há indicação de associar biológico (STEP 5), o qual é indicado para a redução de forma consistente e significativa das exacerbações nos pacientes com asma grave que apresentam limitações de biomarcadores tanto para o uso de omalizumabe (perfil de asma alérgica grave/IgE) quanto para asma eosinofílica grave (Anti IL-5/Eosinófilos), atuando no da cascata inflamatória (alvo a linfopoietina estromal tímica, uma citocina epitelial).
Em repetidos exames, a paciente não apresenta eosinofilia no sangue como biomarcador de inflamação (ou o tem baixo) e também não é compatível com o fenótipo/perfil alérgico. Assim, seguindo as diretrizes nacionais e internacionais que norteiam o tratamento da asma, a idicação recai no início de Tezepelumabe 210mg (Tezspire®), na posologia de 210mg - 1 vez ao mês e sob supervisão, com os objetivos de reduzir a dispneia, as exacerbações, melhorar a qualidade de vida e reduzir também outros riscos futuros causados pelo uso prolongado de altas doses de corticosteroide (hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, glaucoma, depressão, equimose, púrpura, candidíase oral, dentre outros).

Desde o início da medicação, a paciente não fez mais uso de corticoterapia sistêmica (corticoide) e não precisou buscar serviço de pronto-atendimento, bem como não usa mais medicação de resgate. Funcionalmente, repetiu a espirometria e obteve um acréscimo importante de VEF1 e CVF (atualmente, em 61% e 75%, respectivamente). Espirometria anterior (VEF1 56% e CVF 59%). Deve manter a medicação (STEP 5 de ASMA/GINA) por tempo indeterminado. Uso contínuo.

Vale ponderar, ademais, que, havendo previsão para cobertura de determinada doença, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento ao qual deverá se submeter o paciente, ficando tal indicação sob responsabilidade do profissional ou equipe médica responsáveis por seu acompanhamento.

Ocorre que o fato da medicação subcutânea não constar do referido rol não exclui, por si só, a responsabilidade da Operadora, pois a Lei n° 14.454/2022, que alterou a Lei n° 9.656/98, estabeleceu critérios que permitem a cobertura de tratamentos não estejam ali incluídos. Confira-se:

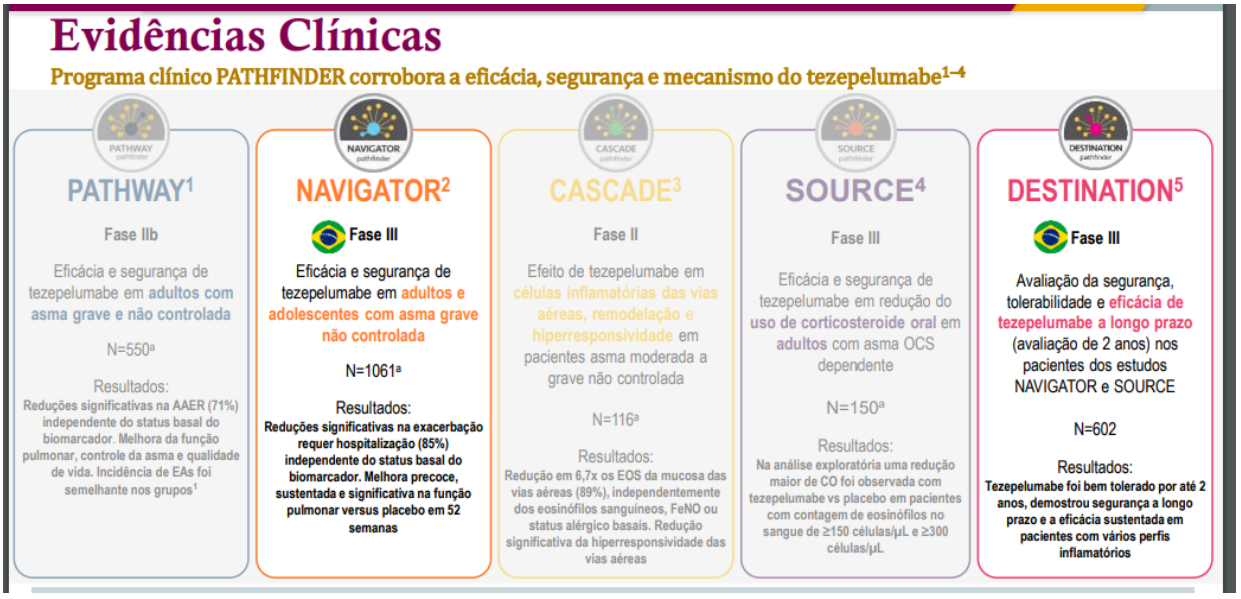
Art. 10. (...)

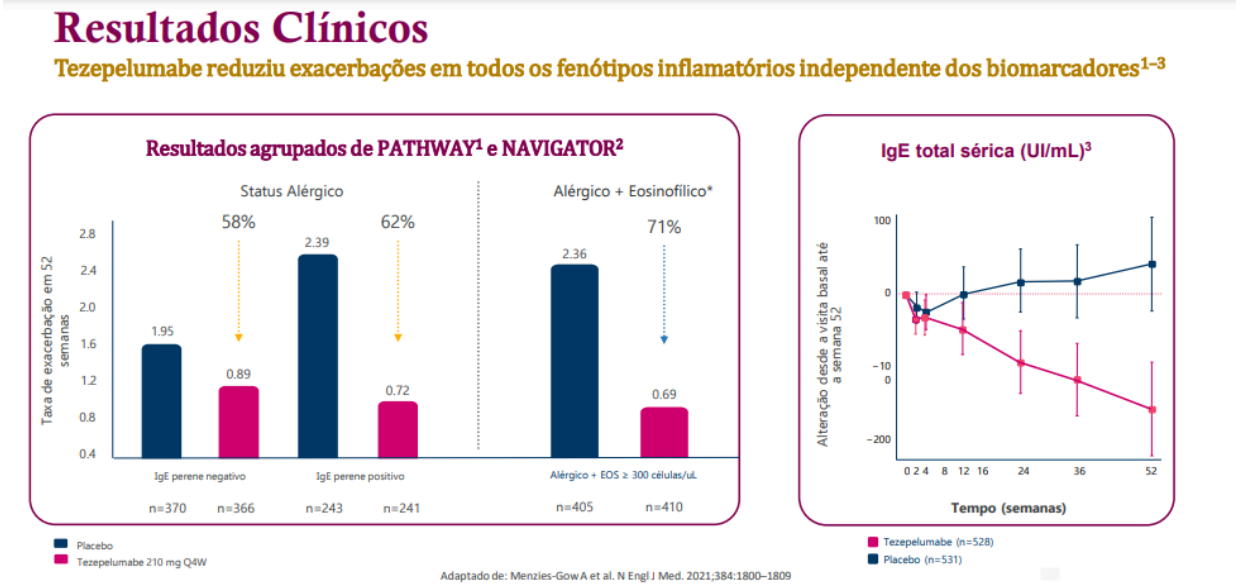
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento **prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:**

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em **evidências científicas** e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, **no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais**

Cumpre destacar que há evidência clínica para o uso do medimento (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp129/copy_of_RT_29_COSAUDE_RP__UAT_118___Tezepelumabe___final.pdf):





Tezepelumabe se mostrou bem avaliado em estudo da Central de Serviços Unimed-RS

O uso de tezepelumabe nas linhas de cuidado de asma grave em nosso meio mostra-se favorável, pela demonstração sólida de benefício clínico em estudos com excelente nível de evidência científica, para os quais não observaram-se critérios de seleção clínica ou laboratorial mais restritos, podendo ser uma alternativa interessante como droga biológica de escolha em protocolo clínicos direcionados ao tratamento da asma grave, uma vez que, além disso, pode trazer redução de custos em relação a outros agentes disponíveis em nosso meio e que podem não oferecer igual benefício em determinadas situações clínicas previamente especificadas.

36

Principais Mensagens

A asma grave corresponde a um menor número de casos em relação a doença que é prevalente no país, **contudo consome a maioria dos recursos** totais no tratamento da asma[1-4]

Tezepelumabe é um imunobiológico anti-TSLP, que **atua no topo da cascata inflamatória da asma, reduzindo múltiplos fatores de inflamação das vias aéreas e hiperresponsividade brônquica,** podendo ser usado em todos os fenótipos da asma grave, **incluindo o fenótipo alérgico**[5]

Tezepelumabe **possui indicação em diretrizes clínicas nacionais e internacionais,** além de **recomendações nas principais agências de ATS do mundo**[6-12]

A incorporação de tezepelumabe propicia **economia para o sistema suplementar de saúde** do país, além de trazer **competitividade comercial** entre diferentes indústrias farmacêuticas, o que leva a **negociações comerciais mais atrativas**

1. Sadatsafavi M et al. Can Respir J. 2010; 17: 74-80 2. SBPT - Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia https://sbpt.org.br/portal/espaco-saude-respiratorio-asma. 3. Oliver A. Nascimento, MD, PhD, et al. The economic impact of asthma on private healthcare system in Brazil: Economic impact of asthma in Brazil. Medicine (2023) 102:12. 4. . J. bras. pneumol. 43 (03) May-Jun 2017; 5. Bula do medicamento tezepelumabe [AstraZeneca]. 6. Global Initiative for Asthma. 2023 GINA MAIN REPORT. Available from: https://ginaasthma.org/2023-gina-main-report/ 7. http://aaai.org.br/diretrizes_artigo.asp?id=1532 8. National Institute for Health and Care Excellende (NICE). Tezepelumab for treating severe asthma. 2023; 9. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Tezepelumab. 2022; 10. Scottish Medicines Consortium (SMC). Tezepelumab (Tezspire). 2023; 11. Haute Autorité de Santé. Tezepelumabe. 2023; 12. Zorginstituut Nederland. GVS-advies tezepelumab (Tezspire®) voor de behandeling van patiënten vanaf 12 jaar met ernstig astma 2023. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2023/08/17/gvs-advies-tezepelumab-tezspire-voor-de-behandeling-van-patienten-vanaf-12-jaar-met-ernstig-astma (accessed October 6, 2023).

Além disso, o tezepelumabe teve eficácia e segurança similares ao dupilumabe em todos os desfechos, com exceção dos resultados a favor do tezepelumabe para a taxa de exacerbação em pacientes com menor contagem de eosinófilos (<150 eosinófilos/µL) e na redução da dose de CO.

Tezepelumabe é recomendado por diversas agências de ATS do mundo independentemente do fenótipo da doença

Entidade		País	Ano
NICE	NICE[1]		2023
CADTH	CADTH[2]		2022*
Scottish Medicines Consortium	SMC[3]		2023
HAS	HAS[4]		2023
Zorginstituut Nederland	ZIN[5]		2023

1. National Institute for Health and Care Excellende (NICE). Tezepelumab for treating severe asthma. 2023; 2. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Tezepelumab. 2022; 3. Scottish Medicines Consortium (SMC). Tezepelumab (Tezspire). 2023;

Por fim, colaciono trecho extraído de nota técnica elaborada pelo NatJus (processo nº 0712909-07.2023.8.07.0018), que guarda relação à lide e denota a eficácia do tratamento proposto:

"O tezepelumabe é um medicamento novo para o tratamento da asma de difícil controle. Ele pode ser uma opção eficaz para pacientes que não respondem adequadamente a outros tratamentos. Os benefícios do tezepelumabe para o paciente com asma de difícil controle incluem: redução dos sintomas da asma, redução das exacerbações da asma, melhora da função pulmonar e da qualidade de vida.

O medicamento também foi associado a uma ***melhora na qualidade de vida dos pacientes com asma de difícil controle.*** *O ensaio clínico de fase 2 PATHWAY reuniu dados de 550 pacientes com asma moderada a grave, com pelo menos duas exacerbações de asma ou uma exacerbação, com necessidade de hospitalização no ano anterior, apesar do uso apropriado de terapias inalatórias (LABA-ICS); foram designados para receber placebo ou uma das três doses diferentes de tezepelumabe (70mg a cada quatro semanas, 210mg a cada quatro semanas ou 280mg a cada duas semanas). Após 52 semanas,* ***os grupos tratados com tezepelumabe apresentaram reduções semelhantes nas taxas de exacerbação em comparação como placebo*** *(reduções relativas de 61%, 71% e 66%, respectivamente). O uso do tezepelumabe também foi avaliado no estudo de fase 3 NAVIGATOR que incluiu 1059 participantes (com idades entre 12 e 80 anos) com asma grave não controlada (618 com contagem de eosinófilos 300 células/microL; 441 com contagem de eosinófilos < 300 células/microL). Tezepelumabe ou placebo foram administrados a cada quatro semanas por 52 semanas em conjunto com a terapia inalatória de controle contínuo.* ***Em média, o tezepelumabe levou a uma redução relativa de 56% na taxa de exacerbação*** *(IC 95% 47-63%). Os pacientes com < 300 eosinófilos/microL apresentaram uma redução clinicamente significativa, mas menor, nas exacerbações (redução relativa de 41%, IC 95% 25- 54%) em comparação com os pacientes com menor ou igual 300 eosinófilos/microL (redução relativa de 70%, IC 95% 60-78%). No grupo de tezepelumabe, 32 exacerbações estiveram associadas a hospitalização ou visita ao pronto-socorro em comparação com 149 no grupo controle (razão de taxa 0,21; IC 95% 0,12-0,37)."*

Nesse cenário, a recusa de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde se mostra ilícita, porquanto há expressa indicação médica para o tratamento em questão pelo médico que acompanha a autora, comprovação de melhora do quadro, evidências científicas sobre o medicamento proposto, bem como recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.

Isso posto, confirmo a tutela de urgência deferida, e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **SUSANA BANDEIRA DE MENEZES** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, a teor do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré ao fornecimento de medicamento **Tezepelumabe (Tezspire)**, conforme receituário e laudo anexos em Evento 1.

Devido a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e fixo honorários advocatícios em R$ 2.500,00 ao patrono da parte autora, a teor do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 30/11/2024, às 18:26:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10072812874v24** e o código CRC **356bac5c**.